Liga Acadêmica Cognitivo-Comportamental (LACC)

ABA e TEA

da análise funcional à decisão clínica

Betina Binatti

24 de outubro de 2026, PUCRS

Quem conduz o workshop

Betina Binatti

- Psicóloga formada pela PUCRS
- Pós-graduada em ABA e Estratégias Naturalistas (Instituto Singular)
- Pós-graduanda em Neuropsicologia (Comportamente)
- 7 anos de experiência em neurodivergência
- 2 anos e 6 meses como coordenadora de caso e supervisora clínica

Ao final, vocês vão conseguir

1. Explicar por que o TEA é heterogêneo
2. **Diferenciar topografia e função**
3. **Identificar antecedentes, consequências e contexto**
4. **Justificar por que avaliar vem antes de intervir**
5. Reconhecer estratégias baseadas em evidências e ligá-las à função
6. Analisar uma vinheta e justificar decisões
7. Reconhecer limites de atuação e a importância da supervisão

Este workshop não forma aplicadores

O que é

Uma introdução ao raciocínio analítico-comportamental aplicado ao TEA.

O que não é

Um curso de formação em ABA. Ele não habilita ninguém a avaliar ou intervir sem formação e supervisão.

Combinados

- Perguntas são bem-vindas a qualquer momento
- Todos os casos são fictícios
- Não vamos discutir casos reais
- Vamos usar “pessoa autista”, respeitando preferências individuais

Uma criança grita e se joga no chão quando a atividade muda.

Por quê?

Exemplo fictício

O diagnóstico de TEA se apoia em dois domínios

Comunicação e interação social

Diferenças persistentes, em vários contextos.

Padrões restritos e repetitivos

De comportamento, interesses ou atividades, incluindo respostas sensoriais.

Os sinais aparecem no início do desenvolvimento e têm impacto significativo no funcionamento.

American Psychiatric Association (2022), DSM-5-TR

Especificadores e níveis de gravidade

Especificadores: com ou sem deficiência intelectual, com ou sem comprometimento de linguagem, condições associadas.

Nível	Necessidade de apoio
1	Exige apoio
2	Exige apoio substancial
3	Exige apoio muito substancial

Os níveis são definidos para cada domínio e descrevem necessidade de apoio, não “grau de autismo”.

O diagnóstico não define o plano

Duas pessoas autistas podem ser muito diferentes em linguagem, capacidade intelectual, necessidade de apoio, condições coocorrentes, interesses e contexto familiar.

O plano nasce da avaliação da pessoa, não do rótulo.

Lord et al. (2020); Lord et al. (2022)

Prevalência depende de onde e como se mede

≈ 1%

Estimativa global (mediana de 100 por 10.000 em estudos de vários países)

1 em 31

Crianças de 8 anos em 16 regiões dos EUA, em 2022

Parte da variação reflete práticas de identificação e acesso a avaliação.

Zeidan et al. (2022); Shaw et al. (2025)

Neurodiversidade: diferença não é algo a “curar”

- O autismo como parte da variação humana
- Reconhecer dificuldades e respeitar a identidade não são opostos
- A linguagem importa: “pessoa autista”, “interesses focados”

Kapp et al. (2013); Bottema-Beutel et al. (2021)

Se o objetivo não é “tirar o autismo”, o que justifica uma intervenção?

ABA é uma ciência aplicada, não um pacote de técnicas

Sete dimensões definem a Análise do Comportamento Aplicada:

- Aplicada
- Comportamental
- Analítica
- Tecnológica
- Conceitualmente sistemática
- Efetiva
- Generalidade

Baer, Wolf & Risley (1968)

Topografia descreve. Função explica.

Topografia

A forma do comportamento: o que se vê e se ouve.

Função

A relação com as consequências que mantêm o comportamento.

A mesma forma pode ter funções diferentes, e formas diferentes podem ter a mesma função.

Exemplo fictício: bater na mesa pode produzir atenção para uma criança e a retirada da tarefa para outra.

Cooper, Heron & Heward (2020); Iwata et al. (1982/1994)

O comportamento acontece entre um antes e um depois

A. Antecedente

O que acontece imediatamente antes

B. Comportamento

O que a pessoa faz, descrito de forma observável

C. Consequência

O que acontece imediatamente depois

Exemplo fictício: a terapeuta guarda o tablet (A), a criança grita e joga o copo no chão (B), o tablet é devolvido (C).

Cooper, Heron & Heward (2020)

O contexto muda o valor das consequências

Variáveis contextuais

Sono, dor, fome, rotina, ambiente sensorial.

Operação motivadora

Altera por um tempo o valor de uma consequência e a frequência dos comportamentos ligados a ela.

Exemplo fictício: depois de uma noite mal dormida, uma tarefa difícil fica mais aversiva, e escapar dela passa a “valer mais”.

Laraway et al. (2003)

Reforçamento se define pelo efeito, não pela intenção

Reforçamento é quando a consequência aumenta a chance de o comportamento voltar a acontecer.

Positivo

Algo é acrescentado. Ex.: a criança recebe atenção.

Negativo

Algo é retirado ou adiado. Ex.: a tarefa sai.

“Negativo” não é punição.

Cooper, Heron & Heward (2020)

Quatro hipóteses funcionais frequentes

1. Acesso a atenção
2. Acesso a itens ou atividades
3. Fuga ou esquiva de demandas ou estímulos
4. Reforçamento automático: o próprio comportamento produz a consequência

São hipóteses a testar, não rótulos. Podem ser múltiplas ou combinadas.

Iwata et al. (1982/1994); Hanley, Iwata & McCord (2003); Hanley et al. (2014)

Mini-exercício em duplas (5 min)

Nas três situações a seguir, o comportamento é o mesmo: **a criança joga os materiais no chão e chora.**

1. O que acontece logo depois?
2. Que hipótese funcional isso sugere?
3. O que vocês precisariam observar mais?

Desafio: pensem em uma estratégia que ajudaria em uma situação e pioraria outra. Por quê?

Três situações

1. A terapeuta se levanta para atender a mãe na porta. A criança joga os materiais e chora. A terapeuta volta, senta ao lado e conversa até ela se acalmar.
2. A terapeuta apresenta uma folha de escrita. A criança joga os materiais e chora. A terapeuta guarda a folha: “fazemos depois”.
3. A terapeuta guarda o tablet. A criança joga os materiais e chora. Minutos depois, ela devolve o tablet “só mais um pouquinho”.

Exemplo fictício

Mesma topografia, três hipóteses

Situação	O que acontece depois	Hipótese
1	A atenção volta	**Acesso a atenção**
2	A tarefa sai	**Fuga da demanda**
3	O tablet volta	**Acesso a item**

Um episódio não basta: hipóteses se sustentam em **padrões que se repetem**.

Hanley (2012)

Cada resposta do início era uma hipótese funcional diferente.

Avaliar vem antes de intervir.

Só a avaliação permite escolher entre elas.

ABA e TCC compartilham compromissos empíricos

- Avaliação de resultados com dados
- Alvos definidos de forma operacional
- Formulação individualizada do caso
- Procedimentos baseados em princípios de aprendizagem, como reforçamento, exposição, modelação e treino de habilidades

Aproximação não é equivalência.

ABA e TCC partem de pressupostos diferentes

	ABA	TCC (modelo de Beck)
Base	Behaviorismo radical	Modelo cognitivo
Pensamentos e sentimentos	Comportamentos a explicar	Mediadores e alvo central
Análise	Relação comportamento–ambiente	Situação, pensamento, emoção e comportamento
Formulação	Análise funcional	Conceituação cognitiva

Skinner (1953); Beck (2021)

No TEA, cada abordagem tem evidências em áreas diferentes

Práticas de base comportamental

Têm critério de evidência: FCT, intervenções antecedentes, reforçamento diferencial, intervenção naturalística, entre outras.

TCC adaptada para autismo

Tem evidência de ensaio clínico para ansiedade em crianças autistas de 7 a 13 anos.

Hume et al. (2021); Wood et al. (2020)

Uma adolescente autista, com boa linguagem, evita trabalhos em grupo e diz ter medo de “falar algo errado”.

O que um analista do comportamento perguntaria primeiro? E um terapeuta cognitivo-comportamental?

Exemplo fictício

Voltamos às 10h45.

Intervalo

Ao voltar, formem grupos de 4 a 6 pessoas.

Três formas de avaliar a função, com limites diferentes

Avaliação	Como	Limite
Indireta	Entrevistas, escalas	Depende do relato de outras pessoas
Descritiva	Observação direta A–B–C	Mostra associação, não causa
Análise funcional	Teste sistemático de condições	Exige profissional qualificado, supervisão e segurança

Hanley, Iwata & McCord (2003); Hanley (2012); BACB (2020)

Prevenir é mudar o contexto, não só reagir

Estratégias antecedentes, escolhidas a partir da hipótese:

- **Previsibilidade:** aviso de transição, apoio visual
- **Ajuste da demanda:** duração, dificuldade, interesse
- **Escolhas** reais
- **Acesso planejado** a pausas e itens preferidos

Cooper, Heron & Heward (2020); Laraway et al. (2003); Hume et al. (2021)

FCT: ensinar a pedir o que o comportamento conseguia

1. Identificar a função
2. Ensinar uma forma de comunicação que produza a mesma consequência (“pausa”, “ajuda”, “mais”)
3. Responder a essa comunicação de forma consistente
4. Ensinar, aos poucos, a esperar e a tolerar um “agora não”

Exemplo fictício: se a hipótese é fuga da tarefa, ensinar a pedir “pausa”, por palavra, gesto, figura ou outro sistema de comunicação.

Carr & Durand (1985); Tiger, Hanley & Bruzek (2008); Hanley et al. (2014)

Ensinar no contexto natural, a partir do interesse da criança

Intervenções Naturalísticas Desenvolvimentais Comportamentais (NDBI):

- Contextos naturais, como o brincar e as rotinas
- Controle compartilhado entre criança e adulto
- Consequências naturais
- Integração entre ciência comportamental e ciência do desenvolvimento

Schreibman et al. (2015); Sandbank et al. (2020)

Generalização precisa ser planejada

Aprender na clínica não garante usar em casa, na escola ou com outras pessoas.

Planejar desde o início: várias pessoas, lugares e materiais, com a família envolvida.

Exemplo fictício: a criança aprende a pedir “pausa” com a terapeuta, e o plano inclui ensinar a família a responder ao mesmo pedido em casa.

Stokes & Baer (1977)

Decidir bem é decidir com ética

- Objetivos com sentido para a vida da pessoa, definidos com a família e com a pessoa
- **Assentimento:** observar sinais de concordância e de recusa
- Não ter como alvo características autistas inofensivas
- Revisar por dados, incluindo possíveis efeitos adversos
- Supervisão e limites de atuação

Breaux & Smith (2023); Sandbank et al. (2023); CFP (2005); BACB (2020)

Atividade em grupos de 4 a 6 pessoas (10 min)

Todos os grupos

Perguntas 1 a 4

Cada grupo, mais uma

Grupo 1: P5. Grupo 2: P6. Grupo 3: P7.
Grupo 4: P5, e assim por diante.

Escolham quem anota e quem apresenta.

A vinheta permite levantar hipóteses, não concluir a função.

Vídeo: Theo, uma sessão

Enquanto assistem (cerca de 30 segundos), observem:

1. O que acontece imediatamente antes?
2. O que exatamente ele faz?
3. O que acontece imediatamente depois?

Animação, exemplo fictício. Não representa uma criança real. O vídeo mostra um episódio; o padrão está na vinheta a seguir.

Vinheta: Theo

Theo tem 6 anos e é autista. Comunica-se principalmente por palavras isoladas e por gestos (puxa o adulto pela mão, aponta). Gosta muito de montar trilhos de trem. Frequenta atendimento clínico três vezes por semana. Nas últimas quatro semanas, a equipe registrou:

- Quando a terapeuta diz “agora acabou, vamos para a mesa”, Theo **grita, se joga no chão e chuta o ar**, por cerca de 3 a 8 minutos. Isso aconteceu em **11 de 12 sessões**, quase sempre na passagem dos trilhos para a atividade de mesa (traçar letras e encaixes).
- Em **duas sessões** em que a terapeuta também guardou os trilhos, mas a atividade seguinte foi o **lanche**, Theo **não** apresentou o comportamento.

Exemplo fictício, parte 1 de 2

Vinheta: Theo (continuação)

- As reações dos adultos variaram: em algumas sessões, a terapeuta esperou e depois **devolveu os trilhos “por mais cinco minutos”**; em outras, **adiou a atividade de mesa** para o fim da sessão; em outras, **manteve a atividade** e conduziu Theo até a mesa.
- A mãe relata que, em casa, Theo reage de forma parecida quando precisa **desligar a televisão para tomar banho**.
- A mãe também conta que, nas semanas em que os episódios foram **mais longos**, Theo **dormiu mal** e houve **troca da terapeuta** que o atendia.
- Nas sessões em que a terapeuta **mostrou um cartão “primeiro trilhos, depois mesa” e avisou dois minutos antes**, os episódios foram **mais curtos** (registro em 3 sessões).

Exemplo fictício, parte 2 de 2

Roteiro de perguntas

Todos os grupos (cerca de 6 min)

1. Descrevam o comportamento de forma que dois observadores concordariam. Que palavras evitaram, e por quê?
2. O que acontece antes? *(rápida)*
3. E depois? *(rápida)*
4. Duas hipóteses funcionais, com **um dado a favor e um contra** cada uma

Rodízio, uma por grupo (cerca de 4 min)

5. Como distinguir H1 de H2? **O que esperariam ver** em cada uma?

6. Uma estratégia para uma hipótese. **E se a hipótese estiver errada?**

7. Dilema: a mãe pergunta se não é melhor **tirar os trilhos de vez**. O que responder?

Plenária: do comportamento à decisão

Topografia → Contexto → Hipóteses → Como distinguir → Estratégias → Ética

Uma vinheta **não permite concluir a função**. Ela permite levantar hipóteses que exigem avaliação adequada.

Hanley et al. (2014)

Cinco mensagens para levar

1. TEA é heterogêneo: **o diagnóstico não define o plano**
2. **Topografia descreve; função explica**
3. **Avaliar vem antes de intervir**
4. Bons objetivos ampliam comunicação, participação, autonomia e qualidade de vida
5. Raciocínio clínico exige **evidência, individualização, ética e supervisão**

Perguntas?

Para aprofundar

Leitura	Tema
Baer, Wolf & Risley (1968)	O que define a ABA
Hanley (2012)	Avaliação funcional na prática
Tiger, Hanley & Bruzek (2008)	Treino de Comunicação Funcional
Schreibman et al. (2015)	Intervenções naturalísticas (NDBI)
Sandbank et al. (2020)	Qualidade da evidência em intervenção precoce
Breaux & Smith (2023)	Assentimento

Referências completas nos slides finais

Betina Binatti

Obrigada!

Workshop ABA e TEA, LACC, PUCRS, 24 de outubro de 2026

Reserva: vinheta da Lara

Lara tem 14 anos, é autista e se comunica oralmente com fluência. Gosta de desenho e de astronomia. Na escola, nos últimos dois meses, quando a professora propõe **trabalhos em grupo** na sala (que costuma ficar barulhenta), Lara **coloca o capuz, abaixa a cabeça e, às vezes, sai da sala** sem avisar. Quando sai, é encaminhada à coordenação e passa o restante da aula na biblioteca. Em atividades individuais, participa e tira boas notas. Contou à psicóloga escolar que “o barulho é demais” e que “sempre fala alguma coisa errada nos grupos”.

1. Descrevam o comportamento de forma observável. Quais são os antecedentes, o contexto e as hipóteses funcionais?
2. O que um analista do comportamento e um terapeuta cognitivo-comportamental perguntariam primeiro?
3. A escola propõe que Lara faça todos os trabalhos sozinha, na biblioteca. Que efeito isso teria a curto e a longo prazo? Que alternativa aumentaria a participação sem ensinar que sair sem avisar é a única forma de conseguir uma pausa?

Exemplo fictício

Reserva: um dado novo sobre Theo

Na semana seguinte, em 4 sessões, a terapeuta apresentou a atividade de mesa **sem guardar os trilhos** (ficaram ao lado, e Theo poderia voltar a eles ao terminar). Em **3 dessas sessões**, Theo não gritou nem se jogou no chão.

Como esse dado muda a força de cada hipótese? Ele permite concluir a função?

Exemplo fictício

Referências: TEA e neurodiversidade

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.

Bottema-Beutel, K., Kapp, S. K., Lester, J. N., Sasson, N. J., & Hand, B. N. (2021). Avoiding ableist language: Suggestions for autism researchers. *Autism in Adulthood, 3*(1), 18–29. https://doi.org/10.1089/aut.2020.0014

Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E., & Hutman, T. (2013). Deficit, difference, or both? Autism and neurodiversity. *Developmental Psychology, 49*(1), 59–71. https://doi.org/10.1037/a0028353

Lord, C., Brugha, T. S., Charman, T., et al. (2020). Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers, 6*, 5. https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4

Lord, C., Charman, T., Havdahl, A., et al. (2022). The Lancet Commission on the future of care and clinical research in autism. *The Lancet, 399*(10321), 271–334. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01541-5

Shaw, K. A., Williams, S., Patrick, M. E., et al. (2025). Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022. *MMWR Surveillance Summaries, 74*(SS-2), 1–22. https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1

Zeidan, J., Fombonne, E., Scorah, J., et al. (2022). Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism Research, 15*(5), 778–790. https://doi.org/10.1002/aur.2696

Referências: ABA e análise funcional

Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. *Journal of Applied Behavior Analysis, 1*(1), 91–97. https://doi.org/10.1901/jaba.1968.1-91

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2020). *Applied behavior analysis* (3rd ed.). Pearson.

Hanley, G. P. (2012). Functional assessment of problem behavior: Dispelling myths, overcoming implementation obstacles, and developing new lore. *Behavior Analysis in Practice, 5*(1), 54–72. https://doi.org/10.1007/BF03391818

Hanley, G. P., Iwata, B. A., & McCord, B. E. (2003). Functional analysis of problem behavior: A review. *Journal of Applied Behavior Analysis, 36*(2), 147–185. https://doi.org/10.1901/jaba.2003.36-147

Hanley, G. P., Jin, C. S., Vanselow, N. R., & Hanratty, L. A. (2014). Producing meaningful improvements in problem behavior of children with autism via synthesized analyses and treatments. *Journal of Applied Behavior Analysis, 47*(1), 16–36. https://doi.org/10.1002/jaba.106

Iwata, B. A., Dorsey, M. F., Slifer, K. J., Bauman, K. E., & Richman, G. S. (1994). Toward a functional analysis of self-injury. *Journal of Applied Behavior Analysis, 27*(2), 197–209. https://doi.org/10.1901/jaba.1994.27-197 (Original publicado em 1982)

Laraway, S., Snycerski, S., Michael, J., & Poling, A. (2003). Motivating operations and terms to describe them: Some further refinements. *Journal of Applied Behavior Analysis, 36*(3), 407–414. https://doi.org/10.1901/jaba.2003.36-407

Referências: ABA, TCC e intervenção

Beck, J. S. (2021). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (3rd ed.). Guilford Press.

Carr, E. G., & Durand, V. M. (1985). Reducing behavior problems through functional communication training. *Journal of Applied Behavior Analysis, 18*(2), 111–126. https://doi.org/10.1901/jaba.1985.18-111

Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (2017). The third wave of cognitive behavioral therapy and the rise of process-based care. *World Psychiatry, 16*(3), 245–246. https://doi.org/10.1002/wps.20442

Hume, K., Steinbrenner, J. R., Odom, S. L., et al. (2021). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism: Third generation review. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 51*(11), 4013–4032. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04844-2

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Tiger, J. H., Hanley, G. P., & Bruzek, J. (2008). Functional communication training: A review and practical guide. *Behavior Analysis in Practice, 1*(1), 16–23. https://doi.org/10.1007/BF03391716

Wood, J. J., Kendall, P. C., Wood, K. S., et al. (2020). Cognitive behavioral treatments for anxiety in children with autism spectrum disorder: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry, 77*(5), 474–483. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.4160

Referências: estratégias naturalistas e evidência

Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley, S., et al. (2020). Project AIM: Autism intervention meta-analysis for studies of young children. *Psychological Bulletin, 146*(1), 1–29. https://doi.org/10.1037/bul0000215

Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley LaPoint, S., et al. (2023). Autism intervention meta-analysis of early childhood studies (Project AIM): Updated systematic review and secondary analysis. *BMJ, 383*, e076733. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076733

Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A. C., et al. (2015). Naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 45*(8), 2411–2428. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2407-8

Stokes, T. F., & Baer, D. M. (1977). An implicit technology of generalization. *Journal of Applied Behavior Analysis, 10*(2), 349–367. https://doi.org/10.1901/jaba.1977.10-349

Referências: ética e assentimento

Behavior Analyst Certification Board. (2020). *Ethics code for behavior analysts*. https://bacb.com/wp-content/ethics-code-for-behavior-analysts/

Breaux, C. A., & Smith, K. (2023). Assent in applied behaviour analysis and positive behaviour support: Ethical considerations and practical recommendations. *International Journal of Developmental Disabilities, 69*(1), 111–121. https://doi.org/10.1080/20473869.2022.2144969

Conselho Federal de Psicologia. (2005). *Código de ética profissional do psicólogo* (Resolução CFP nº 010/2005).

Leaf, J. B., Cihon, J. H., Leaf, R., et al. (2022). Concerns about ABA-based intervention: An evaluation and recommendations. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 52*(6), 2838–2853. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05137-y

Newcomb, E. T., & Wine, B. (2023). A brief response to assent in applied behaviour analysis and positive behaviour support: Ethical considerations and practical recommendations. *International Journal of Developmental Disabilities, 69*(4), 628–629. https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2206686